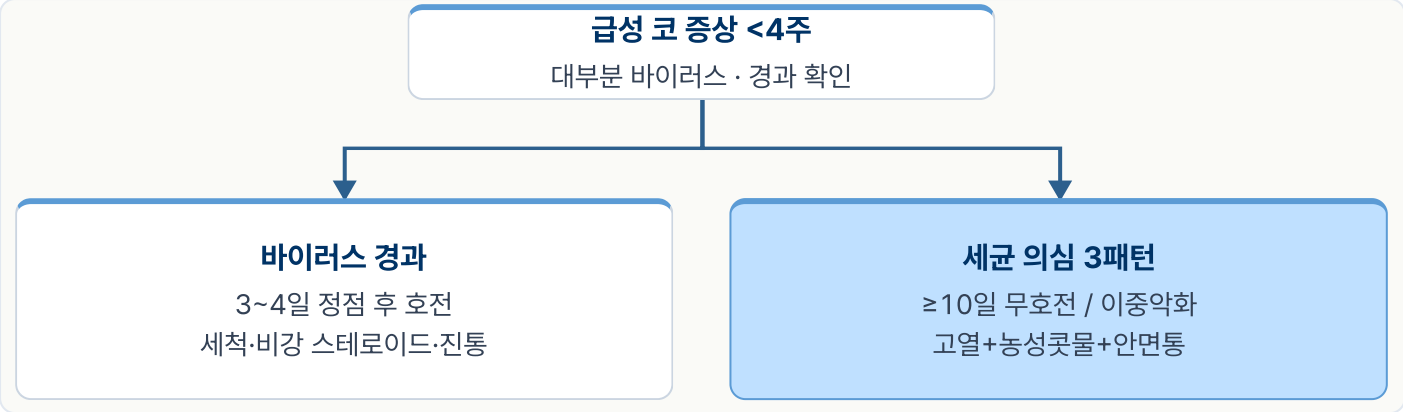
의료진 진료 카드 · ASL-080

급성 비부비동염 · 관찰과 항생제

누런 콧물 자체는 세균의 증거가 아니다. 시간·이중악화·중증 소견으로 구분한다.

세균 의심 패턴과 관찰의 조건



본강의 · ABRS 의심

지속·이중악화	≥10일 호전 없이 지속, 또는 좋아지다 5~6일째 다시 악화. 감기 환자 중 세균 동반 약 0.5~2%로 소개.
중증	고열 ≥39°C + 농성 콧물 + 안면통 3~4일의 교재 기준. 강의 상황표는 고열 39°C·심한 안면통 3일이면 즉시 amox/clav·추적으로 제시.
색깔	노랑·초록은 호중구·myeloperoxidase 색이며 감기 3~4일째 정상 경과에서도 나타남. 색보다 기간과 악화 양상으로 판단.

본강의 · 초기 치료와 안전망

경과관찰	합병증 없는 ABRS는 경과관찰 제시 가능. 진통·해열제, 식염수 세척, 비강 스테로이드로 증상 치료.
안전망 처방	WASP/SNAP: 처방전을 주되 바로 복용하지 않고 3~5일 더 관찰, 호전 없거나 악화하면 시작. 중증 즉시치료 사례와 구분.
급성기 보조	Mometasone은 급성 비부비동염 적응증으로 아침·저녁 사용을 소개. 비강 충혈완화제 >5일 금지. 알레르기 없는 경우 경구 항히스타민 효과는 제한적.

즉시 의뢰 소견: 편측·혈성 분비물, 안와 부종·복시·시력저하, 심한 두통·의식변화·고열·경부강직 등 신경 증상, 면역저하. 합병증 없는 급성 비부비동염의 관찰 경로와 분리한다.

의료진 진료 카드 · ASL-080

급성 세균성 · 성분 함량과 재평가

강의에 제시된 성인 용법. amoxicillin/clavulanate 성분 함량으로 비교하고 설사·실패를 구분한다.

본강의 · 1차 항생제

표준 용법	Amoxicillin/clavulanate 500/125mg 1일 3회 또는 875/125mg 1일 2회, 5~7일. 제품 총량·정수보다 두 성분 함량으로 구분.
고위험	≥65세, 최근 4주 내 항생제·입원, 면역저하, 중증: 고용량 amox/clav, amoxicillin 기준 2g 1일 2회, 7~10일로 소개.
국내 선택 이유	교재: H. influenzae ampicillin 내성 약 58%·β-lactamase 약 52%, M. catarrhalis 거의 100% β-lactamase. 국내에서는 amox 단독보다 병합 선호라는 강의 설명.
재평가	관찰 중 3~5일(최대 약 7일) 무호전이면 항생제 시작 고려. 복용 중 3~5일 무호전이면 바꾸기 전 진단·합병증·순응도 재평가.

연자 Q&A · 설사와 치료 실패

설사·제형	625mg(500/125) 하루 3회 → 1g(875/125) 하루 2회 변경을 우선한다는 답변. 하루 clavulanate 375→250mg으로 줄고 amoxicillin은 증가.
복용·대안	Q&A는 식사 시작 때 복용, S. boulardii·LGG 보조를 제시. Amoxicillin 단독 500mg 하루 3회 또는 875mg 하루 2회도 소개했으나 β-lactamase 균을 놓칠 수 있다고 설명.
설사 위험	열·혈변·복통이 동반되거나 항생제 중단 후 지속하면 C. difficile 평가. 단순 제형 관련 설사와 구분.
무호전	적절한 항생제 3~5일 후에도 무호전이면 세균성인지, 바이러스·알레르기·치성 원인, 눈·머리 합병증, 복용 여부를 먼저 본다. 실패 시 2세대 세파로 하향 변경하지 않고 배양·의뢰 고려.

설사로 약을 바꾸는 상황과 적절한 치료 후에도 감염이 호전되지 않는 상황을 구분한다. 성분 함량·복용법을 확인하고, 지속 설사의 동반 증상과 치료 실패 원인을 다시 평가한다.

의료진 진료 카드 · ASL-080

대체약 · 알레르기와 실패 경로

항생제 변경 전 재평가가 먼저다. 아래 국내 내성·대안은 본강의 및 연자 Q&A의 설명.

본강의 · 대체 항생제의 자리

경구 세파	Amox/clav·levofloxacin 불가 또는 실패 시 cefditoren(메이액트) 1순위, cefpodoxime·cefdinir 차선. Cefuroxime 단독 1차 비권장, cefaclor는 부적절로 소개. 고도 내성 실패 시 경구 세파에도 한계가 있어 ceftriaxone 또는 배양·의뢰.
피하는 경험적 선택	폐렴구균 macrolide 내성 70~80%, TMP/SMX 내성 30~40%+, tetracycline 내성 73~83%로 소개. Macrolide·TMP/SMX·cefaclor·doxycycline을 일률적 경험적 대체로 권하지 않음.
호흡기 FQ	Levofloxacin 내성 3~7%, moxifloxacin <2%로 소개했으나 중증 penicillin 알레르기·치료 실패·내성균 의심 때 제한. 건염·건파열·QT 연장·혈당 이상·말초신경병증·대동맥류/박리 위험.

연자 Q&A · 알레르기와 설사 대안

병력 선별	5년 이내 반응, 아나필락시스·혈관부종, 박리·점막 침범, 응급실·치료 여부 질문. 위험 낮은 병력은 알레르기내과 경구유발검사로 평가 가능하다고 답변.
곁사슬·중증	비중증 병력이고 R1이 다른 세파는 대체 가능성이 있으나, 아나필락시스는 첫 복용 병원 관찰 약 30분 또는 전문의 상의; SJS·DRESS 병력은 베타락탐 회피 후 의뢰라는 답변.
두 계열 진성 알레르기	Levofloxacin 500mg 하루 1회 5~7일 또는 moxifloxacin 400mg 하루 1회 5~7일을 대안으로 설명. 위의 FQ 위험 때문에 꼭 필요한 경우만 사용한다는 답변.
설사 시 cefuroxime	Q&A는 설사 대안으로 cefuroxime axetil 500mg 하루 2회도 소개. 이는 amox/clav 치료 실패 후 2세대로 바꾸지 말라는 설명과 다른 상황.

재평가 뒤 연결

치료 실패

약을 계속 추가하기 전에 진단·복용·치아·안와/신경 합병증을 다시 본다. 세균성 실패면 범위를 조정하거나 내시경·배양 가능한 이비인후과 의뢰.

12주 이상 지속

만성 비부비동염은 내시경/CT 객관 소견을 확인하는 별도 경로. INCS+세척이 중심이며 반복 급성 항생제 처방만으로 해결하지 않는다는 강의 설명.